proregen

GUIA PARA PACIENTES

PRP: o plasma rico em plaquetas

O que é, como é feito e o que a ciência mostra no joelho, no quadril, nos tendões, na coluna e nas feridas. Com honestidade, sem promessas.

Conteúdo educativo. Não substitui a consulta médica.
Baseado em estudos científicos publicados até outubro de 2026.

EDIÇÃO 2026

ANTES DE COMEÇAR

Uma conversa franca sobre o PRP

Talvez você já tenha ouvido falar em tratamento "com o próprio sangue". Este guia explica, em linguagem simples, o que é o PRP, onde ele ajuda, onde ainda está em estudo e onde não mostrou benefício.

O que é o PRP

PRP quer dizer **plasma rico em plaquetas**. As plaquetas são pequenas partes do sangue que ajudam a estancar sangramentos. Elas também liberam substâncias que sinalizam ao corpo que um tecido precisa de reparo.

No PRP, separamos e concentramos essas plaquetas a partir de uma pequena amostra do **seu próprio sangue**. Depois, o concentrado é aplicado no local da lesão.

O PRP é um procedimento médico auxiliar e complementar: não substitui o tratamento clínico, a reabilitação ou a cirurgia indicada.

COMO LER ESTE GUIA

As bolinhas ●●●○○ mostram a força das evidências científicas em cada área: quanto mais bolinhas, mais segura é a informação.

O PRP **não é cura** e não serve para todos. Ele pode fazer parte de um plano que inclui exercícios, fisioterapia e mudanças de hábito.

01	Como o PRP é feito e o que esperar	3
02	Mapa da evidência, área por área	4
03	Joelho: artrose e reparo do menisco	5
04	Cotovelo de tenista	6
05	Disco lombar e outras áreas em pesquisa	7
06	Segurança e quem pode ser candidato	8
07	Perguntas frequentes	9
08	Referências e contato	10

Do seu sangue ao local da lesão

O procedimento é feito em ambiente médico apropriado e costuma durar menos de uma hora. Na coluna, é feito em ambiente hospitalar ou de hospital-dia.

1

Avaliação

Consulta, exame físico e revisão dos exames de imagem. É aqui que se decide se o PRP faz sentido para o seu caso.

2

Coleta do sangue

Uma amostra pequena é coletada da veia do braço, como num exame de sangue comum.

3

Preparo

O sangue vai para uma centrífuga, que separa as plaquetas. Existem tipos diferentes de PRP, com mais ou menos glóbulos brancos. O médico escolhe o tipo conforme a lesão.

4

Aplicação

Após a limpeza da pele, o PRP é injetado no local, muitas vezes guiado por ultrassom para mais precisão. Em alguns casos são feitas 2 ou 3 aplicações, com semanas de intervalo.

5

Recuperação

É comum sentir dor ou inchaço no local por 2 a 3 dias. Em geral, anti-inflamatórios devem ser evitados nesse período, pois podem atrapalhar a ação das plaquetas. O médico orienta repouso relativo e a volta gradual às atividades.

> O QUE ESPERAR
>
> O PRP não age como um analgésico. Quando funciona, a melhora costuma ser gradual, ao longo de semanas, e o resultado varia de pessoa para pessoa. Nenhum resultado pode ser garantido.

Onde o PRP ajuda, onde ainda não sabemos

Resumo do que os estudos mostram hoje. É um ponto de partida para conversar com o seu médico, não uma indicação.

> **O PRP é um procedimento médico auxiliar e complementar. Ele não substitui o tratamento clínico, a reabilitação ou a cirurgia quando indicada.**

ÁREA	FORÇA	O QUE OS ESTUDOS MOSTRAM
Joelho com artrose	●●●●○	Boa evidência
Cotovelo de tenista	●●●●○	Boa evidência
Reparo do menisco (junto com a cirurgia)	●●○○○	Resultados mistos
Disco da coluna lombar	●●○○○	Em estudo

Artrose do joelho

Aplicação no consultório, dentro da articulação. Em geral 2 a 3 sessões, junto com exercícios.

Reparo do menisco

Aplicação durante a cirurgia, no local da sutura. A reabilitação segue o protocolo da cirurgia.

Cotovelo de tenista

Uma aplicação no tendão, guiada por ultrassom, seguida de exercícios para o tendão.

Disco lombar

Em hospital ou hospital-dia, guiada por imagem, após exames que confirmem a origem da dor.

Os estudos usam tipos diferentes de PRP, números de aplicações e protocolos distintos. Por isso, os resultados nem sempre podem ser comparados entre si.

03 · JOELHO

Artrose do joelho e reparo do menisco

Joelho com artrose

BOA EVIDÊNCIA

É a área mais estudada. Em artrose leve a moderada, vários estudos mostram melhora da dor e da função, com resultados comparáveis ou superiores aos do ácido hialurônico e da infiltração com corticoide em alguns estudos. Costuma ser opção quando exercícios e remédios não bastaram, geralmente em 2 a 3 aplicações. Não regenera a cartilagem perdida.

COMO É FEITO

Aplicação dentro da articulação do joelho, muitas vezes guiada por ultrassom.

Em geral são 2 a 3 aplicações, com algumas semanas de intervalo, conforme a avaliação.

DEPOIS DA APLICAÇÃO

Pode haver dor e inchaço por 2 a 3 dias. Gelo e repouso relativo ajudam.

Exercícios de fortalecimento e controle do peso continuam essenciais para o joelho.

Reparo do menisco (junto com a cirurgia)

RESULTADOS MISTOS

Aqui o PRP é aplicado durante a cirurgia que sutura o menisco, como complemento. Algumas revisões de estudos encontraram menos falhas do reparo com PRP, mas outras não mostraram melhora clara na dor e na função. A cirurgia e a reabilitação continuam sendo o tratamento principal.

QUEM COSTUMA SER AVALIADO PARA O PRP NO JOELHO

Pessoas com artrose leve a moderada, confirmada por exame físico e de imagem, que continuam com dor apesar de exercícios, fisioterapia, controle do peso e remédios. Na artrose muito avançada, outras opções, inclusive a cirurgia, podem ser mais adequadas.

O QUE O PRP NÃO FAZ

Não cria cartilagem nova, não corrige o desgaste já instalado e não tem resultado garantido. Ele pode ajudar a aliviar a dor e melhorar a função como parte de um plano completo.

Cotovelo de tenista e a cirurgia do menisco

Cotovelo de tenista

BOA EVIDÊNCIA

Na epicondilite lateral crônica, há estudos de alta qualidade com melhora da dor e da função no médio prazo, com resultados melhores que os do corticoide nesses estudos.

COTOVELO: COMO É FEITO

Uma aplicação no ponto do tendão lesionado, na parte de fora do cotovelo, geralmente guiada por ultrassom.

É indicada quando a dor persiste apesar de repouso, ajustes no esforço e fisioterapia.

COTOVELO: DEPOIS

A dor pode aumentar por alguns dias antes de melhorar.

Os exercícios para o tendão, orientados pelo fisioterapeuta, fazem parte do tratamento.

MENISCO: COMO É FEITO

O PRP é colocado no local da sutura durante a artroscopia, a cirurgia feita por pequenos cortes.

Não muda a técnica cirúrgica: a sutura é o tratamento principal.

MENISCO: DEPOIS

A recuperação segue o protocolo da cirurgia: muletas, carga progressiva e fisioterapia.

O retorno ao esporte depende da cicatrização e da reabilitação, não do PRP.

REABILITAÇÃO É PARTE DO TRATAMENTO

Nas duas situações, o resultado depende muito do que acontece depois: fisioterapia, exercícios em casa e volta gradual ao esforço. O PRP é um complemento desse caminho, nunca um atalho.

QUANDO PROCURAR O MÉDICO ANTES DO RETORNO

Febre, vermelhidão que se espalha, calor intenso no local, ou dor que piora muito depois do terceiro dia.

Disco lombar e áreas em pesquisa

Disco da coluna lombar

EM ESTUDO

Na dor que vem do disco lombar, um ensaio clínico e revisões mostram melhora da dor em parte dos pacientes, mas os estudos ainda são poucos e pequenos. Na coluna, o procedimento é feito em ambiente hospitalar ou de hospital-dia, guiado por imagem.

COMO É FEITO

Só após diagnóstico e exames que confirmem que a dor vem do disco.

Em hospital ou hospital-dia, guiado por imagem, por médico especialista habilitado.

DEPOIS

Repouso relativo nos primeiros dias e retorno gradual às atividades.

Fisioterapia e exercícios para a coluna seguem sendo a base do cuidado.

EM PESQUISA, FORA DAS INDICAÇÕES AUTORIZADAS PELO CFM

Quadril (artrose e dor no glúteo médio), tendão patelar, fascite plantar, tendão de Aquiles, ombro (manguito rotador), ligamento cruzado anterior, cicatrização do osso, articulações e outras regiões da coluna, coluna cervical e feridas crônicas. O PRP vem sendo estudado nessas situações, mas elas não fazem parte das indicações autorizadas pelo Conselho Federal de Medicina. Fale com o seu médico sobre as opções para o seu caso.

Por que só estas quatro indicações?

A Resolução nº 2.464/2026 do Conselho Federal de Medicina autoriza o PRP como procedimento médico auxiliar em quatro situações: artrose do joelho, doença do disco lombar, cotovelo de tenista e reparo do menisco. Ela também exige avaliação individual, consentimento informado e proíbe prometer cura ou resultado.

As demais áreas seguem sendo pesquisadas. À medida que novos estudos surgirem, as recomendações podem mudar.

É seguro?
E é para mim?

O PRP é considerado um procedimento de baixo risco, por usar o sangue do próprio paciente.

Efeitos mais comuns

Dor, inchaço ou rigidez no local por alguns dias. Mancha roxa no braço da coleta.

Raros

Pode ocorrer infecção no local da aplicação, o que é raro quando o procedimento segue técnica estéril.

Procure o médico se houver

- Febre, vermelhidão que se espalha ou calor intenso no local.
- Dor que piora muito depois do terceiro dia.

Pode ser uma opção para quem

Tem diagnóstico confirmado numa área com indicação, já tentou o tratamento básico (exercícios, fisioterapia, controle do peso) e entende que o resultado não é garantido.

Em geral não é indicado

Casos de infecção ativa no local, câncer ativo, doenças do sangue, alterações da coagulação ou plaquetas baixas, uso de alguns anticoagulantes, gravidez, e artrose muito avançada, em que outras opções podem ser melhores.

> **DECISÃO COMPARTILHADA**
>
> A melhor escolha é tomada junto com o seu médico, depois de uma avaliação individual.

Dúvidas que ouvimos no consultório

P Dói?

A coleta é como um exame de sangue. Na aplicação, pode haver desconforto e pressão. Nos dias seguintes, a dor local pode aumentar um pouco antes de melhorar.

P Quantas aplicações são necessárias?

Depende da área e da lesão. Em tendões, muitas vezes uma aplicação. No joelho, os estudos costumam usar 2 a 3.

P Quanto tempo dura o efeito?

Varia de pessoa para pessoa. No joelho, alguns estudos observaram benefício por 6 a 12 meses. Esse é um dado de pesquisa, não é garantia para o seu caso.

P Posso trabalhar no dia seguinte?

Na maioria dos casos, sim, com cuidado e sem esforço intenso no local nos primeiros dias.

P O PRP evita cirurgia?

O PRP não substitui a cirurgia quando ela é indicada. Essa decisão é tomada na avaliação.

P PRP é o mesmo que células-tronco?

Não. O PRP usa plaquetas do sangue. Células-tronco e outros ortobiológicos são tratamentos diferentes.

QUER CONVERSAR SOBRE O SEU CASO?

Agende uma avaliação com o Dr. André Kruel, presencial em Bento Gonçalves (RS) ou por consulta online. WhatsApp (54) 99689-1295 · proregen.com.br

De onde vêm estas informações

1. Le ADK et al. Current clinical recommendations for use of platelet-rich plasma. Curr Rev Musculoskelet Med. 2018;11(4):624-634.
2. Sheean AJ, Anz AW, Bradley JP. Platelet-rich plasma: fundamentals and clinical applications. Arthroscopy. 2021;37(9):2732-2734.
3. Litsos S, Diamantopoulos AP, Molund M. Platelet-rich plasma in the management of musculoskeletal disorders: a narrative review. Front Med. 2026;13:1920226. doi:10.3389/fmed.2026.1920226.
4. Rothrauff BB et al. Platelet-rich plasma in the treatment of musculoskeletal disease in 2025 and beyond. Am J Sports Med. 2026;54(8):2058-2074. doi:10.1177/03635465251395284.
5. Sheth U et al. Efficacy of autologous platelet-rich plasma use for orthopaedic indications: a meta-analysis. J Bone Joint Surg Am. 2012;94(4):298-307.
6. Everts PAM et al. Platelet rich plasma in orthopedic surgical medicine. Platelets. 2021;32(2):163-174.
7. Tuakli-Wosornu YA et al. Lumbar intradiskal platelet-rich plasma injections: a prospective, double-blind, randomized controlled study. PM R. 2016;8(1):1-10.
8. Migliorini F et al. PRP augmentation does not result in more favourable outcomes in arthroscopic meniscal repair: a meta-analysis. J Orthop Traumatol. 2022;23(1):8.
9. Dave U et al. Platelet rich plasma augmentation for meniscus repair reduces failure but not complication rates or outcomes: a systematic review. J Orthop. 2026;73:62-71.
10. Conselho Federal de Medicina. Resolução CFM nº 2.464, de 2 de julho de 2026. DOU 15/07/2026, Seção 1, p. 70.

Responsável técnico

Dr. André Kruel · Médico ortopedista

CRM-RS 23627 · RQE 14323

Contato

Proregen · Bento Gonçalves (RS) e consulta online

WhatsApp (54) 99689-1295 · proregen.com.br

Material educativo. Não substitui a consulta médica. Não contém preços, imagens de "antes e depois" ou depoimentos, conforme as regras de publicidade médica do CFM. Edição outubro de 2026.

proregen